

Система мочевыделения

Блок А (75%)_ ТЗ Форма 1'

Назовите основной этиологический фактор острого гломерулонефрита {

~стафилококк

~клебсиелла

=бета-гемолитический стрептококк группы А

~синегнойная палочка

~пневмококк

}

В каком образовании почки расположен юкта-гломерулярный аппарат

~В лоханке почки

~В петле Генли

~В прямом канальце

=В клубочке почки

~В почечных пирамидках

}

В какой срок после перенесенной инфекции развивается острый
гломерулонефрит

=10-12 дней

~3-4 дня

~неделя

~месяц

~2 месяца

}

Какая возрастная группа наиболее подвержена заболеванию острым
гломерулонефритом {

~до 2 лет

=с 2-летнего возраста и до 40 лет

~климактерический период

~период менопаузы

~пубертатный период

}

Боли в области поясницы при остром гломерулонефрите могут быть связаны с наличием конкрементов в мочевыводящей системе {

=с остро развившейся отечностью почечной ткани

~с апостематозными изменениями паренхимы почек

~с нарушениями уродинамики

~с ишемическим инфарктом почек

}

Что является наиболее важной причиной гипопротеинемии при нефротическом синдроме {

=потеря белков с мочой

~усиленный синтез бета-глобулинов

~перемещение белков из плазмы во
внеклеточную жидкость

~потеря белка через отечную слизистую
оболочку кишечника

~усиленный катаболизм глобулинов

}

При болезни Берге частым симптомом является {

~протеинурия

=гематурия

~увеличение Т-хелперов и снижение Т-суппрессоров

~снижение IgA

~Гипопротеинемия

}

Наиболее важный фактор повреждающего воздействия на канальцы и интерстиций при
гломерулонефрите {

=протеинурия

~эритроцитурия

~трансферинурия

~ухудшение кровоснабжения канальцев

~бактериурия

}

Отметьте современные формы гломерулонефритов {

~мезангио-пролиферативный

=все верно

~IgA нефропатия

~мембранозный

~мембранозно-пролиферативный

}

Какая проба позволяет выявить снижение клубочковой фильтрации при хпн

{

~проба по Нечипоренко

~проба Зимницкого

=проба Реберга

~проба Аддиса-Каковского .

~проба Нечипоренко

}

Наиболее важный показатель для отличия нефротического варианта
гломерулонефрита от сердечных отеков

(застойные почки) {

~отсутствие заболеваний сердца

~локализация отеков на нижних конечностях

~увеличение печени

=высокая протеинурия

~наличие акроцианоза

}

Наиболее характерные признаки хпн {

~тошноты, рвоты

~оглушенность

~боли в животе

~громкое дыхание Куссмауля

=все верно

}

При каком заболевании в моче могут определяться активные лейкоциты {

~гломерулонефрит

=пиелонефрит

~миеломная болезнь

~амилоидоз почек

~инфаркт почки

}

Самым достоверным признаком хпн является {

~артериальная гипертензия

=повышение уровня креатинина в крови

~олигурия

~анемия

~лейкоцитурия

}

Каковы нормальные показатели креатинина у женщин {

=44-97 мкмоль/л

~40- 180мкмоль/л

~50-150 мкмоль/л

~38 -120 мкмоль/л

~38 -120 мкмоль/л

}

Основные жалобы больных с заболеваниями почек {

~отеки

=все перечисленное

~боль в поясничной области

~головная боль

~учащенное мочеиспускание

}

Чем наиболее часто обусловлена головная боль при заболеваниях почек {

=повышением артериального давления

~падением артериального давления

~накоплением азотистых шлаков

~отеком тканей мозга

~интоксикацией продуктами обмена

}

Каково отношение дневного диуреза к ночному в норме {

=3:1

~5:1

~1:1

~4:1

~1:2

}

Наиболее важные признаки, позволяющие исключить наличие пиелонефрита при дифференциации гломеруло- и пиелонефрита {

~гематурия

=протеинурия выше 1 г/л

=отеки

~цилиндры гиалиновые

~температура

}

При излечении в течение какого срока гломерулонефрит считается острым {

~трех месяцев

=года

~шести месяцев

~двух лет

~нескольких лет

}

Лейкоцитурией называется увеличение числа лейкоцитов в моче свыше {

~10 в поле зрения, или 4000 в 1 мл

~3-4 в поле зрения, или 2000 в 1мл

=15 -20 в поле зрения, или > 4000 в 1 мл

~15 -20 в поле зрения, или > 4000 в 1 мл

~15 -20 в поле зрения, или > 4000 в 1 мл

}

Лейкоцитурия может встречаться {

~при пиелонефрите

~при гломерулонефрите

~при амилоидозе

=при всех перечисленных заболеваниях

~при всех перечисленных заболеваниях

}

Максимальная суточная протеинурия в норме составляет {

=50 мг

~100 мг

~150 мг
~300 мг
~500 мг
}

Изостенурия это состояние при котором {
=плотность мочи равна 1010 или плотности плазмы
~плотность мочи ниже 1018
~плотность мочи 1015
~плотность мочи 1013
~плотность мочи 1030
}

Появление мочи цвета "мясных помоев" характерно для {
~острого пиелонефрита
=острого гломерулонефрита
~рака почки
~нефротического синдрома
~хронического пиелонефрита
}

Болевой синдром при остром гломерулонефрите обусловлен {
~нарушением оттока мочи
~воспалительным отеком мочеточника
~растяжением почечной лоханки
~спастическим сокращением мочеточника
=растяжением почечной капсулы
}

Наличие у больной острой односторонней боли в поясничной области с иррадиацией паховую область после тряской езды характерно для {
~паранефрита
~острого пиелонефрита
~острого гломерулонефрита
=мочекаменной болезни
~хронического гломерулонефрита
}

Ноющая тупая, двусторонняя не длительная боль в поясничной области

характерна для {
~инфаркта почки
~опущения почки
~мочекаменной болезни
~перегиба мочеточника
=острого гломерулонефрита
}

Причиной острой односторонней боли в поясничной области с иррадиацией в паховую область, возникшей после чрезмерной физической нагрузки является {
~паранефрит
~острый пиелонефрит
~острый гломерулонефрит
=мочекаменная болезнь
~нефроптоз
}

Учащенное мочеиспускание называется {
=Поллакиурией
~Никтурия
~Полиурия
~Олигурией
~Странгурией
}

Отеки почечного происхождения чаще всего сопровождается следующая окраска кожных покровов {
~Цианотичная
~Красная
=Бледная
~Желтушная
~Обычная, бледно-розовая
}

Для хронического гломерулонефрита характерно все нижеперечисленное за единственным исключением {
~Отеки лица по утрам
~Повышение АД

~Полиурия
~Никтурия
=Повышение относительной плотности мочи
}

Преобладание ночного диуреза над дневным называется {
~Олигурией
~Анурией
=Никтурией
~Поллакиурией
~Странгурией
}

У больного резкая слабость, головная боль, повышение АД, ухудшение зрения, отечность лица, уменьшение выделения мочи и красноватый ее цвет. заболел остро. можно заподозрить {
~Острый пиелонефрит
~Острый пиелит
=Острый гломерулонефрит
~Нефротический синдром
~Уремия
}

Выявляемые пробой по Зимницкому никтурия, гипостенурия и полиурия свидетельствуют о {
~сердечная недостаточность
~сахарный диабет
=хронической почечной недостаточности (ХПН)
~нефротический синдром
~острый гломерулонефрит
}

Что такое гематурия? {
~появление в моче белка;
=появление в моче эритроцитов;
~появление в моче лейкоцитов;
~появление в моче цилиндров.
}

При каком заболевании как правило развивается уремия? {

- ~острый пиелонефрит;
 - =хронический гломерулонефрит;
 - ~острый гломерулонефрит.
 - ~ХПН
 - ~МКБ
- }

Относительные противопоказания для проведения пробы Зимницкого? {

- ~значительная глюкозурия;
 - ~пороки сердца;
 - =прием мочегонных препаратов;
 - ~высокое артериальное давление.
 - ~ХПН
- }

Какую функцию почек отражает проба Зимницкого? {

- =участие в концентрации мочи;
 - ~участие в гемопоэзе;
 - ~участие в обмене электролитов.
 - ~участие в обмене углеводов
 - ~участие в обмене белков
- }

Для пациентов с острым пиелонефритом основными жалобами являются все, кроме: {

- =отеки;
 - ~дизурия;
 - ~повышение температуры;
 - ~боли в поясничной области?
 - ~боли в животе
- }

Каковы особенности почечных отеков? {

- ~начинаются с нижних конечностей;
- ~появляются к вечеру;
- =начинаются с лица;
- ~сопровождаются цианозом.
- ~сопровождается желтушностью

}

Что такое никтурия? {

~задержка выделения мочи;

=преобладание ночного диуреза над дневным;

~снижение удельного веса мочи;

~монотонно сниженный удельный вес мочи.

~болезненное мочеиспускание

}

Что такое изостенурия? {

~одинаковый объем разных порций мочи;

~снижение удельного веса мочи;

=монотонно сниженный удельный вес мочи;

~повышение удельного веса мочи.

~без изменений

}

Для нефротического синдрома характерно все, кроме: {

=анемии;

~значительная протеинурии;

~гиперхолестеринемии;

~гипопротеинемии;

~отеков.

~дислипидемия

}

При каком заболевании бывает часто положительный симптом

Пастернацкого? {

~гломерулонефрит;

=пиелонефрит;

~язвенная болезнь желудка;

~желчнокаменная болезнь.

~гастрит

}

Что такое гипостенурия? {

~уменьшение частоты мочеиспускания;

~уменьшение количества мочи;

=снижение удельного веса мочи;
~одинаковый объем разных порций мочи.
~повышение удельного веса мочи
}

Для какого заболевания характерна моча цвета «мясных помоев»? {
~гемолитическая желтуха;
=острый гломерулонефрит;
~острый пиелонефрит;
~сахарный диабет.
~анемия
}

Что такое пиурия? {
~появление в моче белка;
~появление в моче эритроцитов;
=появление в моче гноя;
~появление в моче цилиндров.
~появление белка и гноя
}

Функциональные пробы при заболеваниях почек? {
~проба Аддиса-Каковского;
~проба Нечипоренко;
=проба Зимницкого;
~проба Квика-Пытеля.
~волдырная проба
}

При каком заболевании встречается пиурия? {
~острый гломерулонефрит;
~рак почки;
=пиелонефрит;
~хронический гломерулонефрит.
~ХПН
}

Как изменяется выделительная способность почек в терминальной стадии ХПН? {

~не изменяется;
=снижается;
~повышается.
~умеренно снижена
}

Что такое анурия? {
=выделение за сутки менее 100 мл мочи;
~выделение за сутки менее 500 мл мочи;
~выделение за сутки менее 200 мл мочи.
~выделение за сутки более 1000 мл мочи
~выделение за сутки менее 1000
}

Для какого заболевания не характерна гематурия? {
~цистит;
=пиелонефрит;
~гломерулонефрит.
~МКБ
~ХПН
}

Трехстаканная проба Томпсона проводится для выявления патологического процесса в: {
~желчном пузыре и желчевыводящих путях;
=мочевыводящих путях;
~бронхах и легких;
~желудочно-кишечном тракте?
~в легочной системе
}

С какой целью проводится анализ мочи по Нечипоренко? {
~для выявления белка в моче;
=для выявления соотношения лейкоцитов и эритроцитов в 1 мл мочи;
~для выявления глюкозы и кетоновых тел в моче.
~для выявления мочевины
~для выявления креатинина
}

С помощью какого исследования можно установить локализацию патологического процесса в органах мочевыделительной системы? {

- ~посев мочи на флору;
 - ~общий анализ мочи;
 - =трехстаканная проба Томпсона.
 - ~проба Нечипоренко
 - ~проба Адисса
- }

Особенности почечной артериальной гипертензии? {

- ~большое пульсовое давление;
 - =повышено больше диастолическое давление;
 - ~повышено только систолическое АД.
 - ~повышено систолическое и диастолическое давление
 - ~пониженное систолическое давление
- }

Бактериологическое исследование мочи необходимо при следующих заболеваниях: {

- =пиелонефрит;
 - ~острый гломерулонефрит;
 - ~хронический гломерулонефрит?
 - ~ХПН
 - ~МКБ
- }

Для какого заболевания характерна поллакиурия? {

- ~острый гломерулонефрит;
 - ~хронический гломерулонефрит;
 - =цистит;
 - ~амилоидоз почек.
 - ~ХПН
- }

Высокий удельный вес мочи характерен для: {

- ~острого пиелонефрита;
- ~хронического гломерулонефрита;
- =сахарного диабета.
- ~ХПН

~МКБ

}

рН мочи (реакция мочи) в норме находится в пределах: {

~4,0-4,5;

=5,0-7,0;

~6,5-9,5;

~2,0-3,5.

~3.0-5.0

}

Кислая реакция мочи бывает: {

=при преобладании в пище животных белков;

~при преобладании растительной пищи;

~при приеме большого количества жидкости;

~при употреблении большого количества фруктов.

~при употреблении большого количества жиров

}

Большое количество кристаллов мочевой кислоты в моче характерно для: {

~острого пиелонефрита;

~острого гломерулонефрита;

~сахарного диабета;

=мочекаменной болезни.

~ХПН

}

Нормативы клубочковой фильтрации? {

~40-60 мл/мин;

=80-120 мл/мин;

~160-180 мл/мин.

~180-190 мл/мин.

~70-80 мл/мин.

}

Выделительную функцию почек можно определить при помощи следующих исследований: {

~анализа мочи по Нечипоренко;

~общего анализа мочи;

=анализа мочи по Зимницкому;
~пробы Квика-Пытеля.
~проба Адисса
}

Концентрационную функцию почек оценивают: {
~по трехстаканной пробе Томпсона;
~по анализу по Нечипоренко;
=по пробе Зимницкого;
~по пробе Квика-Пытеля.
~проба Адисса
}

Эклампсия осложняет течение одного из ниже перечисленных заболеваний?
~острый пиелонефрит;
~хронический пиелонефрит;
=острый гломерулонефрит;
~хронический гломерулонефрит.
~ХПН
}

Кожный зуд при заболеваниях почек обусловлен избыточным содержанием в крови: {
~билирубина;
=мочевины;
~сахара?
~белка
~креатинина
}

Для какого клинического варианта хронического гломерулонефрита характерно повышение артериального давления? {
~нефротического;
=смешанного;
~латентного.
~гематурического
~мезангиокапиллярного
}

Проба Зимницкого позволяет оценить следующие функции почек:

- ~азотовыделительную;
- =концентрационную;
- ~электролитную.
- ~белковую
- ~углеводную
- }

Количество эритроцитов в 1мл в пробе по Нечипоренко в норме не должно превышать?

- ~100;
- =1000;
- ~2000;
- ~4000.
- ~5000
- }

Глюкозурия характерна для: {

- ~острого пиелонефрита;
- ~острого гломерулонефрита;
- =сахарного диабета;
- ~мочекаменной болезни.
- ~ХПН
- }

Появление тонических и клонических судорог характерно для: {

- ~почечной колики;
- ~уремии;
- =почечной эклампсии?
- ~ХПН
- ~МКБ
- }

Бактериологическое исследование мочи показано при следующих заболеваниях? {

- ~острый гломерулонефрит;
- =пиелонефрит;
- ~хронический гломерулонефрит;
- ~амилоидоз почек.

~МКБ
}

Для нефротического синдрома характерно все, кроме: {
Отеки;
~массивная протеинурия;
~гипопротеинемия;
=гиперкалиемия;
~гиперхолестеринемия
}

Изменения чашечно-лоханочной системы почек характерны для: {
=хронического пиелонефрита;
~хронического гломерулонефрита;
~цистита;
~амилоидоза почек.
~ХПН
}

Ведущее место в этиологии пиелонефрита отводят?
=кишечной палочке, протею; {
~стафилококку;
~энтерококку;
~клебсиелле.
~стрептококк
}

Для какого заболевания характерна бактериурия? {
~гломерулонефрит;
=пиелонефрит;
~амилоидоз почек.
~ХПН
~МКБ
}

К развитию хронической почечной недостаточности приводят следующие заболевания? {
~острый пиелонефрит;
~острый гломерулонефрит;

=хронический гломерулонефрит;
~цистит.
~хронический пиелонефрит
}

Какой симптом не характерен для хронической почечной недостаточности? {
~сухость во рту;
~тошнота, рвота;
~кожный зуд;
=кровохарканье;
~жажда;
}

Для терминальной стадии хронической почечной недостаточности
характерны следующие показатели клубочковой фильтрации: {
~80-120 мл/мин;
~50-60 мл/мин;
~30-40 мл/мин;
=менее 20 мл/мин.
~80-120 мл/мин;
}

Количество цилиндров в пробе по Нечипоренко не должно превышать? {
~100;
=250;
~1000;
~2000.
~5000
}

Какое количество мочи свидетельствует о полиурии? {
~800 мл;
~1500 мл;
=2500 мл;
~1000 мл.
~1500
}

Почки пальпируются в следующих положениях пациента, кроме:

~лежа;
~стоя;
=сидя
~полулежа
~в положении ортопное
}

Соотношение дневного и ночного диуреза составляет?

=3 : 1;
~2 : 1;
~1 : 1
~3:2
~4:1
}

Для какого заболевания характерна кетонурия? {

~пиелонефрит;
=с диабет;
~гломерулонефрит;
~мочекаменная болезнь.
~ХПН
}

Для какого заболевания характерна оксалатурия? {

~гломерулонефрит;
~пиелонефрит;
~поликистоз почек;
=мочекаменная болезнь.
~ХПН
}

Выделение за сутки менее 50 мл мочи свидетельствует об: {

~олигоурии;
=анурии;
~полиурии;
~поллакурии.
~изостенурии
}

Назовите основной этиологический фактор острого гломерулонефрита? {

~стафилококк;

~клебсиелла;

= β -гемолитический стрептококк группы А;

~синегнойная палочка;

~пневмококк.

}

В какой срок после перенесенной инфекции развивается острый гломерулонефрит? {

=10-12 дней;

~1-2 дня;

~3 недели;

~месяц.

~год

}

Какие из перечисленных факторов вызывают развитие острого гломерулонефрита? {

~сывороточный;

~вакцинный;

~яд насекомых;

~лекарственные вещества;

=все перечисленные.

}

Какими причинами обусловлены гемодинамические нарушения при остром гломерулонефрите? {

=гиперволемией,

~задержкой натрия и воды;

~снижением общего периферического сопротивления сосудов;

~гиперволемией.

}

Что включает в себя классическая триада симптомов острого гломерулонефрита? {

~отеки, одышка, гематурия;

=отеки, гипертония, гематурия;

~отеки, гипертония, сердцебиение.

}

Клиническими проявлениями *facies nefritica* являются? {

=отеки лица, бледность кожи;

~отеки лица, акрицианоз;

~отеки лица, геморрагическая сыпь на лице.

~отеки ног

~отеки всего тела

}

Что относится к характерным гемодинамическим расстройствам при остром гломерулонефрите? {

=расширение полостей сердца;

~низкое диастолическое давление;

~низкое систолическое давление.

~низкое и систолическое и диастолическое

~низкое пульсовое}

}

Какому фактору придается ведущее значение в патогенезе гипертензии при остром гломерулонефрите? {

~увеличение ОЦК и ударного объема сердца;

=сужение почечных артерий;

~увеличение уровня кортизола в крови.

~увеличение сахара в крови

~увеличение белка

}

С чем могут быть связаны боли в области поясницы при остром гломерулонефрите? {

~с наличием конкрементов в мочевыводящей системе;

=с набуханием почек;

~с апостематозными изменениями паренхимы почек;

~с ишемическим инфарктом почек.

~наличием белка в моче

}

Какой признак является характерным для острого гломерулонефрита? {

~изогипостенурия;

=увеличение плотности мочи;
~снижение плотности мочи;
~увеличение микробного числа мочи.
~увеличением креатинина
}

Что не относится к осложнениям острого гломерулонефрита? {
~олигоанурия в острой фазе заболевания с развитием ОПН;
~эклампсия;
=тромбоэмболический синдром;
~острая левожелудочковая недостаточность.
~острая правожелудочковая недостаточность
}

Какой показатель не относится к диагностическим критериям «нефротического синдрома»? {
~протеинурия более 3,5 г/л;
~гипоальбуминемия;
=гиперпротеинемия;
~гиперхолестеринемия.
~глюкозурия
}

При каких заболеваниях может возникнуть нефротический синдром? {
~сахарный диабет;
~миеломная болезнь;
~амилоидоз;
~опухоли внелегочной локализации;
=при всех перечисленных заболеваниях;
~ни при одном из вышеперечисленных заболеваний.
}

Главным признаком нефротического синдрома является: {
~Лейкоцитурия;
=выраженная протеинурия;
~гематурия;
~цилиндрурия;
~бактериурия?
}

Причиной гипопроteinемии при нефротическом синдроме является все, кроме: {

~потеря белков с мочой;

=усиленный синтез β -глобулинов;

~перемещение белков из плазмы во внеклеточную жидкость;

~потеря белка через отечную слизистую оболочку кишечника?

~потеря жидкости

}

Какой из клинических вариантов хронического гломерулонефрита является самым частым? {

~гематурический;

=латентный;

~нефротический;

~гипертонический;

~смешанный.

}

Какие признаки характерны для мочевого синдрома при хроническом гломерулонефрите? {

~отсутствие протеинурии;

~лейкоцитурия;

=гематурия;

~наличие в моче клеток Штернгеймера-Мальбина.

~наличие бактерий

}

Какой признак характерен для гипертонического варианта хронического гломерулонефрита? {

~выраженный мочевой синдром;

=гипертонический синдром;

~отечный синдром.

~астенический синдром

~анемический

}

Какой признак не характерен для нефротического варианта хронического гломерулонефрита? {

~суточная потеря более 3 г/л;
~отеки;
=макрогематурия.
~ микрогематурия
~бледность
}

Какая проба позволяет выявить снижение клубочковой фильтрации при ХГН? {

~проба по Нечипоренко;
~проба Зимницкого;
=проба Реберга;
~проба Аддиса-Каковского.
~волдырная проба
}

Какой признак позволяет отличить хронический гломерулонефрит от острого?

{
~наличие дизурических расстройств;
=выраженная гипертрофия левого желудочка;
~выраженная лейкоцитурия;
~величина протеинурии.
~выраженная гематурия
}

Какой характерный признак хронического гломерулонефрита позволяет отличить его от эссенциальной артериальной гипертензии? {

~Опережающее мочевого синдром повышение АД;
=Мочевой синдром, предшествующий повышению АД;
~Частое развитие сосудистых осложнений (инсульт, инфаркт);
~Выраженные изменения глазного дна.
~анемия
}

Какой признак помогает отличить нефротический вариант гломерулонефрита от сердечных отеков (застойные почки)? {

~локализация отеков на нижних конечностях и крестце;
~увеличение печени;
=суточная протеинурия более 3 г/л.

~суточная протеинурия менее 3 г/л
~увеличение селезенки
}

Какие изменения биохимических показателей наблюдаются при терминальной ХПН? {
~гипербилирубинемия;
=гиперкреатининемия;
~уробилирубинурия.
~гипергликемия
~ глюкозурия
}

Назовите признак, характерный для уремического перикардита? {
~повышение температуры тела;
~боли в области сердца;
=шум трения перикарда;
~накопление геморрагической жидкости в полости перикарда.
~ накопление жидкости в легких
}

От чего зависит темная и желтоватая окраска кожи при ХПН? {
~повышение прямого билирубина;
~овышение непрямого билирубина;
=анрушение выделения урохромов;
~нарушение секреции билирубина.
~нарушение углеводного обмена
}

При каком заболевании в моче могут определяться клетки Штенгеймера-Мальбина? {
~гломерулонефрит;
=пиелонефрит;
~амилоидоз почек;
~инфаркт почки.
~инфаркт миокарда
}

Самым достоверным признаком ХПН является: {

~артериальная гипертензия;
=гиперкалиемия;
~повышение уровня креатинина крови;
~олигурия;
~анемия?
}

Причины ХПН следующие, кроме: {
~хронический гломерулонефрит;
~хронический пиелонефрит;
=острый внутрисосудистый гемолиз;
~амилоидоз;
~подагра?
}

Для нефротического синдрома характерны все признаки, кроме: {
~гипоальбуминемия;
~суточная потеря белка более 3 г/л;
=изостенурия;
~гиперлипидемия;
~отеки?
}

Определение какого из показателей наиболее информативно для выявления нефротического синдрома? {
=величины протеинурии;
~ клубочковой фильтрации;
~креатинина сыворотки;
~холестерина сыворотки.
~сахара в крови
}

При амилоидозе наиболее часто поражаются органы, кроме: {
~почки;
=сердце;
~селезенка;
~печень?
~легкие
}

Причинами анемии при хронической почечной недостаточности могут быть все, кроме: {

- ~гемолиз;
 - =дефицит фолиевой кислоты;
 - ~дефицит железа;
 - ~недостаток эритропоэтина?
 - ~недостаток железа
- }

При хронической почечной недостаточности анемия является результатом: {

- ~кровотечения их верхних отделов желудочно-кишечного тракта;
 - ~снижения эритропоэтической функции почек;
 - ~воздействия уремических токсинов на костный мозг;
 - ~внутрисосудистого гемолиза;
 - =всех вышеперечисленных причин?
- }

Для определения степени тяжести ХПН имеют значение все показатели, кроме: {

- ~уровень креатинина крови;
 - ~величина клубочковой фильтрации;
 - =выраженность отеочного синдрома;
 - ~выраженность анемии?
 - ~выраженность желтухи
- }

При остром гломерулонефрите справедливы утверждения: {

- ~в начальном периоде артериальная гипертензия развивается у всех пациентов;
 - ~наиболее частой формой болезни является нефротическая;
 - ~все перечисленное верно;
 - =все перечисленное неверно?
- }

Каковы гомеостатические функции почек, кроме: {

- ~поддержание водноэлектролитного обмена;
- ~поддержание кислотно-щелочного гомеостаза;
- ~экскреция конечных продуктов азотистого обмена;

=поддержание артериального давления?

}

Что является структурной и функциональной единицей почек? {

~дочечное тельце;

~долька;

~фолликул;

=нефрон.

}

Значение уровня определения креатинина в моче заключается в том, что: {

=Дает представление о фильтрации в почке;

~Служит показателем интенсивности обмена аммиака;

~Определяет скорость обновления белков мышц;

~Определяет качество работы печени.

ТЗ Форма 2²

Повышение артериального давления при остром гломерулонефрите обусловлено {

~%50% ренин-ангиотензиновым механизмом

~%50% гиперальдостеронизмом

~%-33.33333% повышением активности

калликреин-кининовой системы

~%-33.33333% повышение концентрации

простагландинов

~%-33.33333% Снижением концентрации кининов и

простагландинов

}

Что включает в себя классическая триада симптомов острого гломерулонефрита {

~%33.33333% ~%50% отеки

~%-50% одышка

~%33.33333% гипертония

~%33.33333% гематурия

~%-50% сердцебиение

}

Клиническими проявлениями

facies nefritica являются {

~%33.33333% отеки лица

~%-50% акроцианоз

~%-50% геморрагическая сыпь на лице

~%33.33333% бледность кожи

~%33.33333% сужение глазных щелей.

}

Характерные гемодинамические расстройства при остром гломерулонефрите

{

~%50% повышение артериального давления

~%50% акцент II тона над аортой

~%-33.33333% низкое диастолическое давление

~%-33.33333% низкое пульсовое давление

~%-33.33333% шум Грехема-Стилла

}

Ведущее значение в патогенезе гипертонии при остром гломерулонефрите
придается {

~%50% задержке натрия и воды

~%-33.33333% увеличению ОЦК и ударного объема
сердца

~%50% ренин-ангиотензиновый механизм

~%-33.33333% гиперкатехоламинемии и увеличению
катехоламинов

~%-33.33333% увеличению уровня кортизола в крови

}

Какие два из перечисленных ниже признаков являются характерными для
острого гломерулонефрита {

~%-33.33333% изостенурия

~%50% увеличение плотности мочи

~%50% гематурия

~%-33.33333% увеличение нейтрофилов в моче

~%-33.33333% увеличение лимфоцитов в моче

}

Укажите осложнения острого гломерулонефрита {
~%50% олигоанурия в острой фазе заболевания с развитием ОПН
~%33.33333% массивное почечное кровотечение
~%50% эклампсия
~%33.33333% тромбэмболический синдром
~%33.33333% острая левожелудочковая недостаточность
}

Критериями "нефротического синдрома" являются {
~%33.33333% протеинурия более 3,5 г/сутки
~%33.33333% гипопротейнемия
~%50% гипергаммаглобулинемия
~%33.33333% гиперхолестеринемия
~%50% гиперхолестеринемия
}

Нефротический синдром наиболее часто встречается при {
~%33.33333% одним из вариантов хронического гломерулонефрита
~%33.33333% амилоидозе
~%50% туберкулезе легких
~%50% тромбозе почечных вен
~%33.33333% липоидном нефрозе
}

Главными признаками нефротического синдрома { являются
~%33.33333% лейкоцитурия
~%50% протеинурия
~%33.33333% гематурия
~%33.33333% цилиндрурия
~%50% отеки
}

Назовите заболевания, наиболее часто сопровождающиеся развитием амилоидоза {
~%50% лимфома Ходжкина
~%33.33333% туберкулез
~%50% неспецифический язвенный колит
~%33.33333% ревматоидный артрит
~%33.33333% хронические нагноительные процессы

}

Обострение хронического гломерулонефрита от острого можно распознать по следующим признакам {

~%50% возникает в первые дни после инфекции

~%-33.33333% имеет цикличное течение

~%50% имеет место гипертрофия левого желудочка

~%-33.33333% имеется гипокомплементемия

выявляется нарушение концентрационной функции почек

~%-33.33333% имеется гипокомплементемия

выявляется нарушение концентрационной функции почек

}

Какие признаки характерны для мочевого синдрома при хгн {

~%33.33333% низкая протеинурия

~%-50% лейкоцитурия

~%33.33333% гематурия

~%33.33333% цилиндрурия

~%-50% наличие в моче клеток Штернгеймера-Мальбина

}

Какие признаки характерны для нефротического варианта хгн {

~%-33.33333% гиперпротеинемия

~%50% суточная протеинурия более 3 г/л

~%50% отеки

~%-33.33333% гиполипидемия

~%-33.33333% макрогематурия

}

Какие признаки являются типичными для нефритического синдрома {

~%50% острое начало, нарастание отеков, протеинурии, гематурии

~%-33.33333% гипотония

~%-33.33333% полиурия

~%-33.33333% лихорадка

~%50% олигурия

}

Какие признаки позволяют отличить хГН от острого пиелонефрита {

- ~%-33.33333% Гипокомплементемия
 - ~%50% выраженная гипертрофия левого желудочка
 - ~%50% уменьшение размеров почек
 - ~%-33.33333% выраженная лейкоцитурия
 - ~%-33.33333% снижение артериального давления
- }

Какие признаки позволяют отличить хГН от хронического пиелонефрита {

- ~%-33.33333% лихорадка с ознобом
 - ~%-33.33333% асимметрия поражения почек
 - ~%50% отсутствие асимметрии поражения почек
 - ~%50% высокая протеинурия в сочетании с гематурией и цилиндрурией
 - ~%-33.33333% высокая лейкоцитурия, бактериурия
- }

Какие характерные признаки хГН позволяют отличить его от гипертонической болезни {

- ~%-33.33333% повышение АД, опережающее мочевого синдром
 - ~%50% мочевого синдром, предшествующий повышению АД
 - ~%-33.33333% частое развитие сосудистых осложнений (инсульт, инфаркт)
 - ~%50% редкость гипертонических кризов
 - ~%-33.33333% выраженные изменения глазного дна
- }

Какие из признаков несут информацию о функциональных способностях почки {

- ~%-50% содержание белка в моче
 - ~%-50% содержание эритроцитов
 - ~%33.33333% снижение клубочковой фильтрации
 - ~%33.33333% повышение мочевины
 - ~%33.33333% повышение креатинина в плазме
- }

По какому показателю мы судим о концентрационной функции почек {
~%-33.33333% уровень белка
~%-33.33333% количество эритроцитов
~%-50% относительная плотность мочи
~%-33.33333% суточный диурез
~%-50% креатинин крови
}

Какие показатели характерны для хпн {
~%-33.33333% протеинурия
~%-50% гематурия
~%-50% цилиндрурия
~%-33.33333% креатинемия
~%-33.33333% повышение уровня мочевины крови
}

При каких заболеваниях почек может наблюдаться боль в поясничной области {
~%-50% амилоидоз
~%-33.33333% пиелонефрит
~%-50% паранефрит
~%-33.33333% почечно-каменная болезнь
~%-33.33333% опухоли почек
}

Наиболее важные признаки, позволяющие исключить наличие пиелонефрита при дифференциации гломеруло- и пиелонефрита {
~%-33.33333% гематурия
~%-50% протеинурия выше 1 г/л
~%-50% отеки
~%-33.33333% цилиндры гиалиновые
~%-33.33333% температура
}

Для внешнего вида больного с нефротическим синдромом характерно {
~%-33.33333% цвет кожи "кофе с молоком"
~%-33.33333% бронзовый оттенок кожи
~%-33.33333% цианоз губ, мочек ушей, пальцев рук
~%-50% выраженная отечность лица
}

~%50% выраженная отечность нижних
конечностей
}

Ведущими механизмами отеков при остром нефротическом синдроме
является {

~%33.33333% повышение проницаемости стенки
капилляров

~%33.33333% уменьшение онкотического давления
плазмы крови

~%33.33333% задержка в крови и тканях ионов натрия

~%-50% острая задержка выделения мочи почками

~%-50% повышение гидростатического давления в
капиллярах

}